

Praktická príloha: Algoritmus manažmentu IgA nefropatie podľa KDIGO 2025 s ohľadom na KDOQI US Commentary

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 19.06.2026

Tento algoritmus je upravený do podoby stručnej praktickej prílohy na jednu stranu A4. Zmysel je jednoduchý: správne rozpoznať podozrenie na IgA nefropatiu, potvrdiť diagnózu biopsiou, odhadnúť riziko progresie a zvoliť liečbu, ktorá cieľi na mechanizmy ochorenia a na spomalenie straty funkcie obličiek.

0) Keď uvažovať o ďalšom kroku

- ☐ Podozrenie na IgAN: perzistujúca hematuria a/alebo proteinúria u dospelého, po vylúčení bežných alternatívnych príčin.
- ☐ Zásadné pravidlo: diagnózu IgAN potvrdzuje **biopsia obličiek**.

1) Kedy poslať pacienta na biopsiu

- ☐ Zvážiť biopsiu, ak dospelý má **proteinúriu $\geq 0,5$ g/deň** alebo ekvivalent.
- ☐ Biopsiu nepovažovať za „voliteľnú“, ak výsledok zásadne zmení liečbu a nie sú kontraindikácie.
- ☐ Do dokumentácie uviesť: hematuriu a proteinúriu s kvantifikáciou, vylúčenie významnej alternatívy príčiny, eGFR a komorbidity relevantné pre riziko biopsie.

2) Po biopsii: ako nastaviť riziko a cieľ liečby

- ☐ Po potvrdení IgAN určiť rizikovosť najmä podľa **eGFR** a **proteinúrie**; histologické parametre využiť podľa Oxford klasifikácie.
- ☐ Cieľ liečby: znížiť proteinúriu čo najskôr a čo najviac, prakticky minimálne **$< 0,5$ g/deň**, ideálne **$< 0,3$ g/deň**, ak je to dosiahnuteľné.
- ☐ Súčasne sledovať spomalenie poklesu eGFR, tlak krvi a kardiovaskulárne riziká.

3) Základ pre všetkých

- ☐ Sodík **< 2 g/deň**.
- ☐ Zanechať fajčenie aj vaping.
- ☐ Kontrola hmotnosti a aeróbna aktivita podľa tolerancie.
- ☐ Cieľ tlaku krvi približne **$\leq 120/70$ mm Hg**, podľa individuálnej tolerancie.
- ☐ Ak je indikovaná a tolerovaná, použiť **blokádu RAS** (ACEi/ARB).
- ☐ Zvážiť **SGLT2 inhibíciu**, ak je pre pacienta indikovaná a realizovateľná.
- ☐ Po týchto krokoch re-evaluovať proteinúriu trendom, nie jednorazovou hodnotou.

4) Ktorých pacientov liečiť cielenejšie

- ☐ Špecifickú liečbu zvažovať pri vyššom riziku progresie, najmä pri pretrvávajúcej proteinúrii napriek základnej renoprotekcii.
- ☐ Pri rozhodovaní zohľadniť eGFR, proteinúriu, histológiu, komorbidity a dostupnosť liečby.

5) Voľba špecifickej liečby

A) Ak je dostupný Nefecon

- ☐ Zvážiť **9-mesačný cyklus** u rizikových pacientov podľa KDIGO.
- ☐ Pacientovi vysvetliť, že hodnotí sa najmä dlhodobější trend eGFR a proteinúrie, nie iba krátkodobá zmena po začiatku liečby.
- ☐ Po vysadení môže pretrvávať len čiastočný „legacy effect“ na proteinúriu.

B) Ak Nefecon nie je dostupný

- ☐ Zvážiť režim so **zníženou dávkou systémových glukokortikoidov** a s profylaxiou podľa rizika a lokálnych pravidiel.
- ☐ Myslieť na infekčné riziko, gastroprotekcii a ochranu kostí podľa kontextu.
- ☐ Pri voľbe liečby zohľadniť diabetes, latentné infekcie, stav kostí a dostupnosť lieku.

6) Monitorovanie liečby

- ☐ Sledovať **proteinúriu** ako hlavný ukazovateľ účinku.
- ☐ Sledovať **eGFR** a tlak krvi.
- ☐ Pri kortikoidoch sledovať bezpečnostné parametre podľa rizika a zvoleného režimu.
- ☐ Pri nečakanom alebo nekompatibilnom priebehu prehodnotiť adherenciu, základnú liečbu a diferenciálnu diagnostiku.

7) Praktická veta do dokumentácie

„Pacient s IgA nefropatiou: diagnóza potvrdená biopsiou. Zavedené základné renoprotektívne opatrenia a ciele tlaku krvi. Pri riziku progresie zvolená cielenejšia liečba (Nefecon, ak je dostupný; inak znížené systémové steroidy s profylaxiou). Účinok hodnotím najmä podľa trendu proteinúrie a eGFR.“

Zdroj: KDOQI US Commentary on the KDIGO 2025 Clinical Practice Guideline for IgA Nephropathy and IgA Vasculitis (AJKD, full text). [Link na zdroj](#).

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=iga-nefropatia-algoritmus-kdigo-2025-kdoqi> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.